

CAPÍTULO 10.8

Adenitis Infecciosa, Adenitis Submandibular y Flemón del Piso de la Boca

PERFIL EUNACOM 1.05.1.008

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Adenitis Infecciosa y Flemón de Piso de Boca

Adenopatía vs. Adenitis Infecciosa

- **Adenopatía:** Ganglio aumentado de volumen (múltiples causas).
- **Adenitis infecciosa:** Ganglio inflamado e infectado con signos inflamatorios (eritema, dolor, calor). Puede complicarse con absceso o fístula.
- Localización más clásica: **Submandibular y cervical**.

Diagnóstico Diferencial por Evolución

TABLA 10.8.1: EVOLUCIÓN VS SOSPECHA		
EVOLUCIÓN	SOSPECHA	CONDUCTA
Aguda (< 1 semana), unilateral, con eritema + calor	Adenitis bacteriana (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes)	ATB + Punción si sospecha de absceso
Bilateral , sin signos inflamatorios intensos	Virus respiratorio	Sintomático
Subaguda (> 1-2 semanas), fistuliza material caseoso	TBC (Escrófula)	Estudio TBC → RHZE
En niños, gato como antecedente	Enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae)	Azitromicina
Adenopatía + odinofagia + fiebre	Síndrome mononucleósico (VEB, CMV)	Confirmar con IgM VCA

Tratamiento Antibiótico de la Adenitis Infecciosa Bacteriana

- **Primera línea:** Amoxicilina + Ácido Clavulánico (cubre Staphylococcus y Streptococcus).
- Si alergia: Clindamicina o Cefalosporinas 1ª-2ª generación (Cefalexina, Cefuroxima).
- Si hay asociación a enfermedad dental/periodontal: Amoxicilina-clavulánico o Clindamicina (cubren anaerobios de cavidad oral).
- Si no responde al ATB → **Punción con aguja fina** para descartar y drenar absceso.

Flemón de Piso de la Boca (Angina de Ludwig)

Definición: Celulitis/flemón (edema e inflamación infecciosa SIN colección) del piso de la boca.

Diferencia clave: Flemón vs. Absceso

TABLA 10.8.2: CARACTERÍSTICA VS FLEMÓN		
CARACTERÍSTICA	FLEMÓN	ABSCESO
Colección purulenta	No	Sí
Diagnóstico confirmatorio	TAC (descarta colección)	TAC o Punción
Drenaje quirúrgico	No (nada que drenar)	Sí
Tratamiento	ATB EV de amplio espectro	ATB EV + Drenaje

EUNACOM CRITERIOS

Regla de oro: Siempre pedir **TAC de cuello** ante sospecha de flemón o absceso cervical/submandibular para diferenciarlos y definir si se drena o no.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 35 años con adenopatía submandibular única, dolorosa, eritematosa, de 5 días de evolución. Se inicia amoxicilina-clavulánico sin mejoría a los 5 días. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Adenitis Infecciosa, Adenitis Submandibular y Flemón del Piso de la Boca. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Adenitis infecciosa aguda: ganglio único, rojo, doloroso. Agentes: estafilococo aureus y estreptococo piógenes. Tratamiento: amoxicilina-clavulánico.
- Si no responde a antibióticos: punción con aguja fina para descartar absceso.
- Asociada a enfermedad dental: cubrir anaerobios orales con amoxi-clavulánico o clindamicina.
- Adenitis subaguda: pensar en TBC (escrófula), Bartonella (arañazo de gato, azitromicina), síndrome mononucleósico.
- Flemón: inflamación infecciosa SIN colección. Absceso: CON colección. Diferencia por TAC.
- Flemón: antibióticos EV sin cirugía. Absceso: antibióticos MÁS drenaje quirúrgico.
- Angina de Ludwig = flemón del piso de la boca.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ADENITIS INFECCIOSA, ADENITIS SUBMANDIBULAR Y FLEMÓN DEL PISO DE LA BOCA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 35 años con adenopatía submandibular única, dolorosa, eritematosa, de 5 días de evolución. Se inicia amoxicilina-clavulánico sin mejoría a los 5 días. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Cambiar antibiótico a clindamicina
- B)** Punción con aguja fina de la adenopatía
- C)** Solicitar biopsia excisional
- D)** Agregar metronidazol al tratamiento
- E)** Solicitar TAC de cuello de inmediato

PREGUNTA 2

Paciente con aumento de volumen submandibular doloroso, fiebre y eritema difuso sin colección palpable. El TAC de cuello no muestra colección. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Absceso submandibular; drenaje quirúrgico más antibióticos
- B)** Flemón submandibular; antibióticos endovenosos de amplio espectro
- C)** Adenitis aguda; amoxicilina-clavulánico oral
- D)** Angina de Ludwig; drenaje quirúrgico urgente
- E)** Celulitis; cloxacilina oral

PREGUNTA 3

Niño de 8 años con adenopatía cervical de 3 semanas de evolución, que fistuliza y drena material blanquecino similar a tiza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Adenitis aguda por estafilococo aureus
- B)** Enfermedad por arañazo de gato
- C)** Tuberculosis ganglionar (escrófula)
- D)** Linfoma de Hodgkin
- E)** Mononucleosis infecciosa

RESUMEN: ADENITIS INFECCIOSA, ADENITIS SUBMANDIBULAR Y FLEMÓN DEL PISO DE LA BOCA

Esta clase cubre adenitis infecciosa, flemón y absceso cervical. La adenopatía es un ganglio aumentado de volumen, siendo las infecciones virales respiratorias la causa más frecuente. La adenitis infecciosa aguda es un ganglio único, rojo, doloroso, con signos inflamatorios, causado por bacterias gram positivas (estafilococo aureus y estreptococo piógenos). Se trata con amoxicilina-ácido clavulánico o clindamicina. Si no responde, punción con aguja fina para descartar absceso. Si hay enfermedad dental/periodontal asociada, cubrir anaerobios con amoxicilina-clavulánico o clindamicina. La adenitis subaguda (>1-2 semanas) orienta a TBC (fistuliza con caseum = escrófula), enfermedad por arañazo de gato (azitromicina) o síndrome mononucleósico (VEB, CMV, toxoplasma). La adenitis bilateral sugiere virus respiratorio (tratamiento sintomático). El flemón es edema inflamatorio infeccioso sin colección (sin absceso). Se diferencia del absceso por TAC. El flemón se trata con antibióticos EV sin cirugía. El absceso requiere antibióticos más drenaje quirúrgico. Las localizaciones clásicas de flemón son submandibular, piso de la boca (angina de Ludwig) y cuello.